结直肠癌疼痛中西医结合诊疗指南

编制说明

提出单位：北京大学肿瘤医院、中国中医科学院西苑医院
归口单位：中华中医药学会
主要起草单位：国家中医药管理局重大疑难疾病中西医结合试点项目（结直肠癌）—结直肠癌疼痛子项目组（北京大学肿瘤医院、中国中医科学院西苑医院）
主要起草人：李萍萍、杨宇飞、吴煜、孙红、薛冬、李占东、王薇、张彤、崔宁

二〇二二年十二月

目次

一、工作简况……3
二、指南编制原则和关键技术内容……3
三、主要工作过程……4
四、与国内外同类指南的对比和最新指南采用情况……23
五、与现行强制性国家标准或政策法规的关系……23
六、代表性分歧意见的处理经过和依据……23
七、宣传、贯彻指南和后效评价指南的要求和措施……23
八、附录……24

结直肠癌疼痛中西医结合诊疗指南编制说明

一、工作简况

1.任务背景

癌性疼痛是肿瘤常见的主要症状之一。据统计，约 1/3 接受癌症治疗的患者出现疼痛，超过 2/3 的进展期癌症患者出现疼痛，约 50%疼痛为中度至重度，其中约 30%为重度疼痛。癌痛给患者造成极大的身心负担，严重影响了患者的生活质量。在结直肠癌疼痛的规范化治疗中，我们发现中药的使用较为普遍。西药治疗癌痛，疗效确切，起效快，但具有比较明显的毒副作用。中医药治疗疼痛历史悠久，古方众多。近年来国内大量文献报道了采用中医药内服、外用、针灸等方法开展对癌性疼痛的治疗，具有毒副作用小、使用安全、无成瘾性和无戒断性等优势。至今国内外尚无在癌痛规范治疗如何使用中药方面的共识或指南。如何体现我国中西医结合的治疗特色，做到既发挥中医特长，又根据目前的研究证据等级合理使用中药止痛，把止痛中药与癌痛三阶梯治疗的有机结合，根据疼痛性质合理使用中成药，是本诊疗方案的需要解决的问题。

2.任务来源

本任务来源于国家中医药管理局重大疑难疾病中西医结合试点项目（结直肠癌）—结直肠癌疼痛子项目组，由北京大学肿瘤医院、中国中医科学院西苑医院两家机构完成，立项时间是 2020 年 3 月 9 日。

3.指南起草单位

北京大学肿瘤医院、中国中医科学院西苑医院。

二、指南的编制原则和关键技术内容

1.指南的编制依据和原则

指南编制流程和方法所依据的原则为《中华中医药学会中医指南制定的技术方案》。

描述指南文本撰写所依据的原则为《标准化工作导则 标准的结构和编写 GB/T1.1-2009》、《中华中医药学会中医指南报告清单》。

2.指南的关键技术内容

本指南的主要临床问题是中西医结合治疗结直肠癌疼痛是否优于单纯西医治疗？主要评价指标为降低疼痛评分、增加疼痛缓解率、降低不良反应、提高生活质量。本方案包括结直肠癌疼痛的病因及分类、结直肠癌疼痛的评估、结直肠癌疼痛的中西医结合治疗等方面。证据分级标准参考刘建平教授在《中医药循证医学》中提出的传统医学证据体的构成及证据分级的建议，本指南结合临床实际作适当修订，推荐意见分级包括：强推荐（或强不推荐）、弱推荐（或弱不推荐）、无明确推荐。结直肠癌疼痛的中医辨证分型分为湿热证、血瘀证、气滞证、阳虚

证、阴虚证，主要方剂分别为槐角丸、血府逐瘀汤、六磨饮子、理中汤、芍药甘草汤。结直肠癌疼痛常用中成药分为活血消癥止痛、解毒消癥止痛、理气止痛，清热止痛、散寒止痛。常用剂型包括口服剂型、注射剂、外用剂型等。在临床应用时，应该首选口服剂型，在中医辨证前提下酌情选用。本方案推荐依据包括：NCCN 成人癌痛指南（2020 版）、北京市癌症疼痛治疗规范（2017 版）、难治性癌痛专家共识（2017 年版）、中华人民共和国药典（2015 版）、中华人民共和国药典.临床用药须知.中药成方制剂卷（2010 版）、中医经典著作、临床研究文献等。

三、主要工作过程

（一）提案、申请、立项

本方案依托国家中医药管理局重大疑难疾病中西医结合试点项目（结直肠癌）—结直肠癌疼痛子项目组，参照北京市疼痛治疗质量控制和改进中心癌痛专家组制定的《癌痛规范化治疗中成药合理使用专家共识》，由北京大学肿瘤医院、中国中医科学院西苑医院两院肿瘤疼痛领域的专家讨论针对结直肠癌疼痛的特点提案并申请立项。于 2020 年 3 月 9 日在中华中医药学会立项。提案申请及立项审查会议纪要见附件 1-5。

（二）成立指南起草组

1.指南起草组成立方式

指南起草组成员是由课题负责人李萍萍、吴煜召集两院癌痛治疗方面的专家多次召开会议、面对面沟通，然后报到总课题负责人确定的。本诊疗方案制订工作的指导组涵盖了国内肿瘤疼痛领域的中医、西医专家，循证医学、药学等学科人员。

2.指南起草组组成情况

（1）指南起草组组成情况

本指南参与起草单位为国家中医药管理局重大疑难疾病中西医结合试点项目（结直肠癌）—结直肠癌疼痛子项目组的负责单位北京大学肿瘤医院、中国中医科学院西苑医院，北京大学肿瘤医院为三级甲等肿瘤专科医院，中国中医科学院西苑医院为三级甲等中医院。本指南主要起草人主任医师 5 人，副主任医师 3 人，主治医师 1 人，副主任药师 1 人，统计学专家研究员 1 人。

（2）指南起草组成员名单及分工

指南起草组成员及其工作内容

序号	姓名	单位	职务/职称	专业	学位	工作内容
1	李萍萍	北京大学肿瘤医院	主任医师、教授	中西医结合肿瘤	学士	指南负责
2	吴煜	中国中医科学院西苑医院	主任医师、教授	中医肿瘤	硕士	指南负责

3	杨宇飞	中国中医科学院西苑医院	主任医师、教授	中医肿瘤	硕士	指南指导
4	孙红	北京大学肿瘤医院	主任医师	中西医结合肿瘤	硕士	指南起草
5	薛冬	北京大学肿瘤医院	主任医师	中西医结合肿瘤	博士	指南起草
6	李占东	北京大学肿瘤医院	副主任医师	中西医结合肿瘤	硕士	秘书、指南撰写
7	王薇	北京大学肿瘤医院	副主任医师	中西医结合肿瘤	博士	指南起草
8	张彤	中国中医科学院西苑医院	副主任医师	中医肿瘤	博士	指南起草
9	崔宁	中国中医科学院西苑医院	主治医师	中医肿瘤	博士	秘书、指南撰写
10	刘倩	北京大学肿瘤医院	副主任药师	药学	硕士	指南起草
11	何英剑	北京大学肿瘤医院	研究员	统计学	博士	统计学处理

3.利益冲突声明

指南起草组成员均填写了利益声明表，不存在与本指南直接的利益冲突。

（三）确定指南的题目和范围

和范围确定的方法和过程。指南题目的确定是按照国家中医药管理局重大疑难疾病中西医结合试点项目（结直肠癌）—结直肠癌疼痛子项目组的计划要求，参照北京市疼痛治疗质量控制和改进中心癌痛专家组制定的《癌痛规范化治疗中成药合理使用专家共识》，确定题目为《结直肠癌疼痛中西医结合诊疗方案》，内容由北京大学肿瘤医院、中国中医科学院西苑医院两院肿瘤疼痛领域的专家讨论，针对结直肠癌疼痛的特点，按照ICD10编码，咨询本领域的权威专家，将指南范围确定为结直肠癌疼痛的中西医结合诊疗方案。希望本方案对在两院开展结直肠癌疼痛临床诊疗工作时能够进一步规范结直肠癌疼痛中西医结合诊疗，提升结直肠癌疼痛中西医结合治疗水平，从而提高结直肠癌疼痛患者的生活质量。将来进一步推广到全国，进一步提升了结直肠癌疼痛单病种的诊疗水平。

（四）构建指南问题

1.专家访谈

（1）访谈方案确定过程及方法

1、因疫情原因，将通过微信word文档进行，进行提问式访谈，有2个西医专家（吴晓明、张艳华），7个中医专家（谢广茹、吴敏慧、贾立群、孙韬、侯丽、孙红、王薇），方法学专家（易丹辉）不参与访谈。

（2）受访专家名单

序号	姓名	单位	学历	职称

1	谢广茹	天津医科大学附属肿瘤医院	本科	主任医师
2	吴敏慧	陕西省肿瘤医院	本科	主任医师
3	吴晓明	中国医学医科院肿瘤医院	本科	主任医师
4	贾立群	卫生部中日友好医院	研究生	主任医师
5	孙韬	北京中医药大学东方医院	研究生	主任医师
6	侯丽	北京中医药大学东直门医院	研究生	主任医师
7	孙红	北京大学肿瘤医院	研究生	主任医师
8	王薇	北京大学肿瘤医院	研究生	副主任医师
9	易丹辉	中国人民大学	研究生	教授
10	张艳华	北京大学肿瘤医院	本科	主任药师

（3）访谈提纲：

草拟了确定临床问题（PICO）如何采用中西医结合的方法规范地治疗结直肠癌疼痛？

P结直肠癌疼痛患者

I中西医结合镇痛治疗方案

C西医镇痛治疗方案

O患者疼痛控制率、生活质量、西药镇痛药物副作用的发生率。听取专家意见，进行归纳总结。

采用德尔菲法

（4）访谈结论

本指南应该包括：

一、合理使用止痛中药的意义

癌痛管理的概念

止痛中药使用中的问题

合理使用止痛中药的重要性

二、止痛中药的定义、证据等级分类（口服、外用）

药典

经典

验方（参考文献）

三、根据目前依据推荐应用的范围

轻度疼痛

中重度阿片类药物的辅助治疗

减轻阿片类药物副作用（便秘等）

四、阿片类药物副作用的中药预防和治疗

便秘

恶心

2.临床调研（详见附件6-8）

（1）调研方案确定的过程及方法

工作组通过文献检索和对诊疗结直肠癌疼痛拥有丰富经验的专家进行访谈相结合的形式确定了初步的临床问题，再通过两轮德尔菲法专家问询的方法和质量控制，2020年9月23日至9月27日通过问卷形式发出问卷106份。问询了 96名临床医生，2名护师，1名研究生、1名结直肠癌患者、6名其他人员。

（2）调研对象分布情况

调查对象地区涵盖6个省市，21家医院。共96名临床医生，2名护师，1名研究生、1名结直肠癌患者、6名其他人员参与该研究。其中主任医师占26.4%，副主任医师占25.5%，主治医师占33.0%，住院医师8.5%，在读研究生0.9%，其他5.7%。医院包括：北京大学肿瘤医院、中国医学科学院肿瘤医院、中日友好医院、北京市朝阳区桓兴肿瘤医院、北京世纪坛医院、北医三院、西苑医院、北京朝阳医院、中国中医科学院广安门医院、首都医科大学附属北京中医医院、东方医院、首都医科大学大兴医院、大兴区人民医院、望京医院、东直门医院、山西省临汾市第二人民医院、临汾市中医医院、江西省肿瘤医院、青岛市中心医院、贵州中医药大学第一附属医院、武汉市东湖医院（武汉市老年病医院）。

（3）调研结论

确立了本指南拟解决的1个临床问题，中西医结合治疗结直肠癌疼痛是否优于单纯西医治疗？该临床问题从以下9个方面进行回答：（1）中医药在结直肠癌疼痛治疗中的主要作用；（2）止痛中药的应用原则；（3）中医药在结直肠癌疼痛治疗中的方法；（4）中医药在结直肠癌疼痛治疗的评价方法；（5）中医药如何与癌痛三阶梯治疗相结合治疗；（6）结直肠癌疼痛的中医辨证治疗；（7）止痛中成药的使用：（8）中医药干预阿片类药物引起的不良反应；（9）中医药在治疗结直肠癌疼痛方面的注意事项。

3.指南问题原始清单

临床问题清单

临床问题	P	I	C	O
1.中西医结合治疗结直肠癌疼痛是否优于单纯西医治疗？	结直肠癌疼痛患者	中西医结合治疗	西医治疗	降低疼痛评分、增加疼痛缓解率、降低不良反应、提高生活质量

4.指南问题

（1）指南问题形成方法

临床问题论证会（附件6）

2020年12月27日于北京裕龙酒店进行了该指南临床问题专家论证会，指南工作组将问题清单递交给专家组，由专家组对指南问题进行共识。

1.原则

(1)采用名义组法共识会议，会议由第三方人员主持;(2)参与临床问题论证的专家为指南专家组成员(不少于2/3);(3)超过参会专家70%以上同意的指南问题,即为确定的指南问题;(4)根据实际情况，确定是否存在待确定的指南问题，原则上 50%-70%专家同意的问题为待确定指南问题;(5)会议投票最多不得超过 3 轮。

2.流程

（1）指南主要起草人或秘书介绍指南问题形成的过程;（2）指南主要起草人解读指南问题清单;（3）专家组对指南问题进行投票;（4）工作组对投票结果进行统计，公布本轮投票已确定的指南问题和待确定的指南问题;（5）专家组对待确定的指南问题逐一进行发言讨论。

3.结果

共有28名专家与会,其中参与临床问题论证的专家为指南专家组成员(不少于2/3),每位专家基于其临床经验,对其合理性进行评价,评价标准为“合理——纳入指南”；“不确定——修改后再讨论”；“不合理——可不纳入指南”。通过专家讨论及论证表结果整合后,得出本指南要解决的最终问题:

1、中医药在结直肠癌疼痛治疗中的主要作用

2、止痛中药的应用原则

3、中医药在结直肠癌疼痛治疗中的方法

4、中医药在结直肠癌疼痛治疗的评价方法

5、中医药如何与癌痛三阶梯治疗相结合治疗

6、结直肠癌疼痛的中医辨证治疗

7、根据疼痛病因使用中成药

8、中医药干预阿片类药物引起的不良反应

9、中医药在治疗结直肠癌疼痛方面的注意事项。

（2）指南问题清单

临床问题清单

临床问题	P	I	C	O
1.中西医结合治疗结直肠癌疼痛是否优于单纯西医治疗？	结直肠癌疼痛患者	中西医结合治疗	西医治疗	降低疼痛评分、增加疼痛缓解率、降低不良反应、提高生活质量

（五）证据的检索、筛选、提取与综合

1.证据检索（附件9）

（1）检索方法

临床研究文献检索的研究类型包括系统综述/Meta 分析、随机对照试验（RCT)、非随机临床对照试验、队列研究等检索数据库包括，中文数据库：CNKI、万方数据知识服务平台、重庆维普中文科技期刊数据库、中国生物医学文献服务系统，英文数据库：PubMed、MEDLINE。检索策略：中文检索词：结肠癌 or 直肠癌 or 结直肠癌 or 大肠癌 or 胃肠道肿瘤 and 疼痛 or 癌性疼痛 or 癌痛 and 中药 or 中医药 or 中西医 or 中成药 or 针灸。英文检索词:Colon Cancer or Rectal Cancer or Colorectal Cancer or Gastrointestinal Tumor And Pain or Cancer

Pain And Traditional Chinese Medicine or Herbal Hedicine or Traditional Chinese and Western Medicine or Chinese Patent Medicine or Acupuncture or Traditional Medicine or Combined Medicine or Alternative Therapy or Supplementary Alternative Medicine。检索字段：标题(title) 、摘要(abstract)、关键词(key words) 、全文(all fields)。检索时间：从建库至 2021 年 8 月 31 日。

（2）检索结果

英文检索结果：无中医药治疗结直肠癌疼痛的文献，有针灸治疗结直肠癌术后恢复和奥沙利铂末梢神经毒性的文献，无结直肠癌疼痛的针灸文献。结直肠癌疼痛的主要中医辨证及代表方剂：未检索到关于结直肠癌疼痛的中医辨证研究。止痛中成药共检索出3123篇文献。其中中文文献3123篇，英文文献0篇。

2.证据筛选和资料提取（附件9）

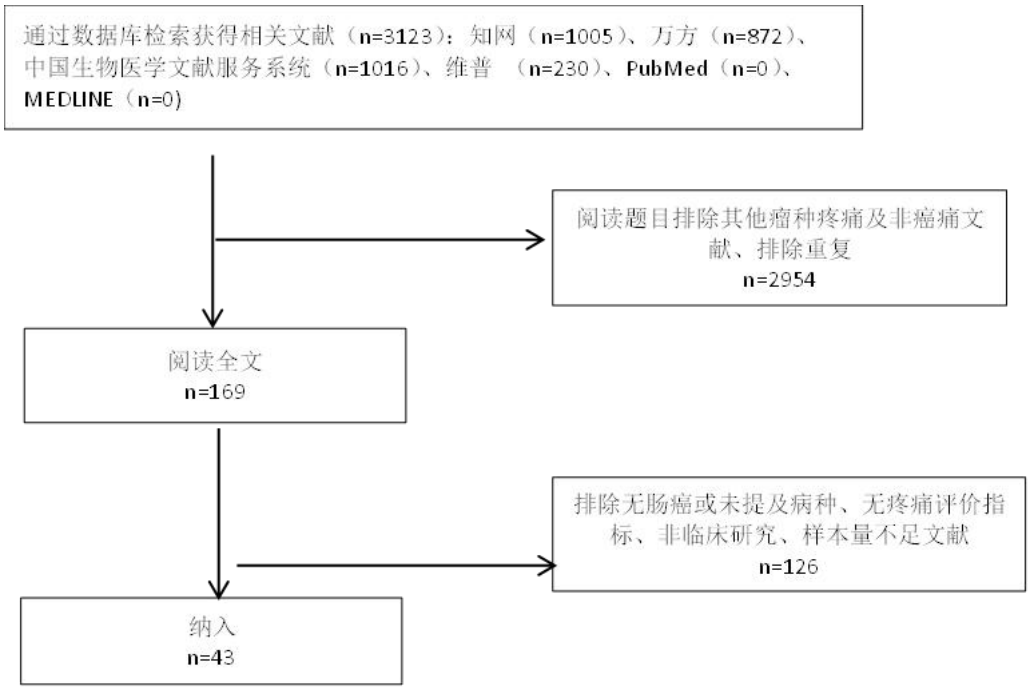
（1）证据筛选和资料提取方法

共检索出3123篇文献。其中中文文献3123篇，英文文献0篇。阅读题目排除其他瘤种疼痛及非癌痛文献后，剔除重复文献，获得文献169篇。再通过阅读全文和摘要，排除无肠癌或未提及病种、无疼痛评价指标、非临床研究、样本量不足文献126篇，最终获得与本研究的结局指标相关的文献共 43篇，其中 43篇中文文献和 0 篇英文文献。

（2）纳入排除标准

纳入标准：（1）文献类型：临床研究文献，研究类型包括系统综述/Meta 分析、随机对照试验（RCT）、非随机临床对照试验、队列研究等；（2）研究对象：结直肠癌疼痛患者或者研究文献中包含结直肠癌疼痛患者；（3）每篇文献中病例观察的样本含量实验组和对照组均≥30例；（4）结局指标：文献中有明确的疼痛评估指标及疗效评价标准。

（3）证据筛选流程及结果



3.证据综合（附件10）

一、无中医药治疗结直肠癌疼痛的文献，有针灸治疗结直肠癌术后恢复和奥沙利铂末梢神经毒性的文献，无结直肠癌疼痛的针灸文献。结直肠癌疼痛的主要中医辨证及代表方剂：未检索到关于结直肠癌疼痛的中医辨证的临床研究文献。所以针灸、中医辨证方药治疗结直肠癌疼痛证据不足。

二、中成药治疗结直肠癌疼痛的文献较多，包括中成药联合化疗，中成药联合镇痛西药，中成药单独应用等，结局指标包括疼痛评分、疼痛缓解率、不良反应发生率、生活质量。中成药治疗结直肠癌疼痛证据详细如下：

1、复方斑蝥胶囊

复方斑蝥胶囊，无专门针对结直肠癌疼痛的研究，有一篇随机对照研究中提示复方斑蝥胶囊联合化疗对217例中晚期恶性肿瘤具有减轻疼痛的作用，其中大肠癌疼痛患者29例。

2、复方夏天无片

复方夏天无片，无专门针对结直肠癌疼痛的研究，有一篇随机对照研究中提示对于轻度癌痛76例复方夏天无片与双氯芬酸纳肠溶片疗效相当，副作用减少，其中结肠癌19例。有一篇对照研究中提示胃肠道肿瘤疼痛患者30例，与常规化疗相比复方夏天无片联合化疗止痛效果明显，其中结直肠癌15例。

3、华蟾素

关于华蟾素治疗结直肠疼痛的研究15篇，其中华蟾素治疗癌痛Meta分析1篇，华蟾素胶囊联合化疗治疗晚期结直肠癌的系统评价与Meta分析2篇。许晶等做了华蟾素治疗癌痛有效性和安全性的系统评价和 Meta 分析，最终纳入 10 个研究，总样本量为 1 293 例，试验组 648 例，对照组 645 例，所纳入研究总体质量普遍偏低。Meta 分析结果显示：华蟾素联合西药止痛药治疗癌痛在近期疼痛缓解效果、提高生活质量和便秘、恶心呕吐、头晕、嗜睡、厌食等不良反应发生方面优于单用西药止痛药，并且具有止痛起效时间短，维持时间长的优势，但不能降低排尿困难的发生率。金金等做了华蟾素胶囊联合化疗治疗晚期结直肠癌的系统评价与Meta分析，共纳入 9 项 RCTs涉及 658 例结直肠癌患者，试验组均为华蟾素胶囊联合化疗药物，对照组为单用化疗药物。Meta 分析结果显示，华蟾素胶囊联合化疗药物在近期有效率、患者生活质量、疼痛缓解率方面明显优于单纯使用化疗药物，并可降低白细胞毒性、胃肠不良反应、肝功能异常、手足麻木的发生率。彭莹莹等做了华蟾素胶囊联合奥沙利铂化疗方案治疗结直肠癌的 Meta 分析，共纳入 8 个 RCT研究，505 例结直肠癌患者，Meta 分析结果显示华蟾素胶囊联合奥沙利铂化疗方案治疗结直肠癌的临床疗效、生活质量、疼痛缓解优于对照组，不良反应低于对照组。RCT研究12篇，共纳入406肠癌疼痛患者。其中3篇为化疗联合华蟾素胶囊对疼痛控制效果优于单纯化疗，7篇为西医镇痛治疗联合华蟾素优于单纯西医镇痛治疗，1篇为伊班膦酸联合华蟾素注射液镇痛效果优于单纯伊班膦酸骨转移疼痛，1篇为华蟾素注射液与美施康定对比镇痛效果相当，但生活质量更优。

4、元胡止痛片（颗粒）

元胡止痛片（颗粒），无专门针对结直肠癌疼痛研究，有一篇RCT研究提示元胡止痛胶囊联合吗啡缓释片对比单纯吗啡缓释片，镇痛效果相当，但元胡止痛片能够降低吗啡缓释片使用剂量及不良反应，具体病种不详。证据等级Ⅱ级，推荐意见为弱推荐。

5、桂参镇痛合剂

无专门针对结直肠癌疼痛研究，有3篇RCT研究针对癌痛的随机对照研究，提及肠癌或者胃肠道肿瘤。研究显示桂参止痛合剂具有明显镇痛作用，对中晚期癌性疼痛患者止痛效果优于强痛定片，且有改善肿瘤患者临床症状、提高生活质量的作用，无恶心呕吐、便秘副作用。

6、草乌甲素片（胶丸）

无专门针对结直肠癌疼痛研究，1篇单独应用草乌甲素治疗轻中度癌痛的随机对照研究，纳入肠癌13例，研究显示对于轻中度癌痛草乌甲素镇痛效果不劣于芬必得、曲马多，副作用更小，生活质量更佳。

7、新癀片

无专门针对结直肠癌疼痛研究，有一篇RCT研究联合美施康定治疗重度癌痛96例的随机对照研究，纳入结直肠癌8例，结果显示应用新癀片配合美施康定治疗重度癌痛患者可增加镇痛疗效，减轻便秘等副反应。有1篇病例观察单独应用新癀片治疗92例癌痛，纳入直肠癌4例，结果显示新瘤片对实体瘤所致的疼痛均有较好的效果，尤其是Ⅰ、Ⅱ级疼痛患者，不但起效较快，止痛维持时间较长，未发现恶心 、呕吐、腹痛、腹泻等副作用，但上消化道出血者禁用，胃、十二指肠溃疡患者慎用。

8、复方苦参注射液

关于复方苦参注射液治疗结直肠疼痛的研究7篇，其中治疗癌痛Meta分析3篇，治疗结直肠疼痛RCT研究4篇。李德辉等通过对纳入的 9 篇文献、997例癌痛患者进行 Meta 分析，结果显示：与单纯用奥施康定治疗癌痛比较，复方苦参注射液联合奥施康定的镇痛有效率增加，病人生活质量提高，恶心呕吐等不良反应发生率降低。黄奕雪等共纳入 21 篇随机对照试验，包括1903个患者，复方苦参注射液联合止痛药对于癌痛的疗效优于单纯使用止痛药，且能够辅助降低单纯使用止痛药的不良反应。陈芝强等纳入7个随机对照试验，共558名患者，Meta分析结果显示：复方苦参注射液联合唑来膦酸治疗骨性癌痛患者在疼痛缓解率方面优于单用唑来膦酸治疗，且联合用药未明显增加毒副反应。一篇研究显示复方苦参注射液联合化疗治疗结直肠癌骨转移疼痛与单纯化疗组比较，疼痛有效率、生活质量均占优，纳入大肠癌82例。一篇研究显示复方苦参注射液联合奥施康定治疗中晚期肠癌癌性疼痛患者能有效减轻疼痛程度和提高生存质量，效果优于单纯奥施康定治疗，不良反应发生率相似，纳入大肠癌64例。另一篇文献研究显示复方苦参注射液联合奥施康定治疗中晚期肠癌癌性疼痛疼痛评分、疼痛缓解率、生活质量均优于单纯奥施康定组，纳入大肠癌100例。一篇研究应用艾灸配合复方苦参注射液治疗的直肠癌性疼痛，疼痛缓解率、疼痛强度差、生命质量评分均高于西药止痛组，纳入直肠癌60例。

9、康莱特注射液（胶囊）

关于康莱特注射液（胶囊）治疗结直肠疼痛的研究9篇，1篇meta分析，8篇RCT研究。廖剑锋等做了康莱特联合化疗与单纯化疗治疗结直肠癌的meta分析，纳入9篇研究，共610例患者，结果显示，康莱特联合化疗组治疗结直肠癌的疼痛总缓解率优于单独化疗治疗组。其中1篇研究采用奥施康定联合康莱特注射液治疗中晚期癌痛患者，与单独使用奥施康定相比，不仅有更好的镇痛作用，并可明显改善患者的生存质量，纳入直肠癌10例。一篇研究采用康莱特注射液+最佳支持治疗生活质量和癌痛缓解率优于最佳支持治疗，纳入肠癌16例。一篇康莱特注射液+营养支持治疗+三阶梯阵痛治疗对比营养支持治疗+三阶梯阵痛治疗，治疗组与对照组比较疼痛缓解率、KPS评分、体重评分有明显提高。一篇康莱特注射液控制癌痛 及提高晚期癌症患者生存质量的多中心Ⅲ期研究，纳入14 家肿瘤医院 376 例晚期癌症，其中伴有癌症疼痛患者 328 例，占 87.23 %（328/376），研究显示康莱特注射液癌症疼痛控制总有效率达 80.49 %（部分缓解 56.10%，完全缓解 24.39 %），用药结束后疼痛缓解仍可维持 1～7 天以上，且无成瘾性，纳入大肠癌28例。一篇研究显示康莱特与吗啡缓释片合用可明显提高重度癌性疼痛患者的镇痛效果，减少吗啡缓释片用量，改善患者生活质量。一篇研究显示最佳支持治疗联合康莱特能够有效改善老年晚期消化道肿瘤的生活质量、缓解疼痛，纳入大肠癌15例。一篇研究显示康莱特注射液联合FOLFOX4方案治疗晚期结直肠癌不仅能增加临床获益率，同时还能改善患者的身体状况和生活质量及缓解疼痛、降低不良反应的发生率，纳入大肠癌60例。一篇研究显示康莱特注射液联合FOLFOX4方案治疗晚期结直肠癌肝转移，联合化疗组在缓解患者的临床症状疗效较好，KPS评分和疼痛缓解率均优于单纯化疗组，而且联合化疗组化疗的不良反应也相应较轻，纳入大肠癌66例。

10、湿润烧伤膏

RCT研究1篇，文献研究显示，湿润烧伤膏治疗放射性皮炎、疼痛缓解情况均优于红霉素软膏对照组，其中纳入直肠癌11例。

11、如意金黄散

外用用于治疗化疗引起的静脉炎RCT研究1篇，研究显示醋调如意金黄散加冰敷治疗化疗药引起的非外渗性静脉炎疗效(86.27%)优于对照组硫酸镁(50.98%)。

12、参芍片（胶囊）无癌痛相关文献，证据不足。

13、阴虚胃痛颗粒（片）无癌痛相关文献，文献证据不足。

（六）证据分级

1.证据分级方法

证据分级标准参考刘建平教授在《中医药循证医学》中提出的传统医学证据体的构成及证据分级的建议，本指南结合临床实际作适当修订。

Ⅰa：在随机对照试验、队列研究、病例对照研究、病例系列这四种研究中，至少2种不同的类型的研究构成的证据体，且不同研究结果的效应一致；实施较好的Meta分析或系统评价。

Ⅰb：具有足够把握度的单个随机对照试验。

Ⅱa：非随机对照研究或队列研究(有对照的前瞻性研究)。

Ⅱb：病例对照研究。

Ⅲa：历史性对照的系列病例。

Ⅲb：自身前后对照的病例系列。

Ⅳ： 长期在临床上广泛运用的病例报告和史料记载的疗法;方向共识意见。

Ⅴ： 未经系统研究验证的方向观点和临床经验，以及没有长期在临床上广泛运用的病例报告和史料记载的疗法。

2.证据概要表（附件11）

证据概要表

纳入研究	样本量干预组/对照组	其中纳入肠癌样本量	性别男/女	干预措施			结局指标
				治疗组	对照组	疗程/d	
董毅，2012[1]	109/108	14/15	153/64	常规化疗+复方斑蝥胶囊	常规化疗	不详	①NRS 评分+③KPS 评分
邹方友，2011[2]	38/38	9/10	42/34	复方夏天无片	双氯酚酸钠肠溶片	14	①VAS 评分+②
李琦，2008[3]	30/30	9/6	42/18	AF 方案化疗+复方夏天无片	AF 方案化疗	63	①《现代麻醉学》分级标准
杨宏，2018[7]	46/46	46/46	57/35	SOX 方案化疗+华蟾素	SOX	84	①NRS 评分+②
王晓珊，2017[8]	60/60	23/20	68/52	三阶梯止痛+华蟾素胶囊	三阶梯止痛	不详	①NRS 评分+②+③KPS 评分
杨庆伟，2021[9]	31/31	31/31	45/17	XELOX 方案化疗+华蟾素胶囊	XELOX 方案化疗	128	①VAS 评分+②+③KPS 评分
钟俐强，2019[10]	44/42	44/42	55/31	CapeOX+华蟾素胶囊案治疗	CapeOX	42	①NRS 评分+②
张益，2021[11]	50/50	15	52/48	盐酸羟考酮缓释片+华蟾素胶囊	盐酸羟考酮缓释片	14	①NRS 评分+②+③KPS 评分、BPQ
梁会敏，2021[12]	39/39	6/5	45/33	三阶梯止痛+华	三阶梯止痛	28	①NRS 评分+②+③KPS 评分

				蟾素胶囊			
刘云霞，2005[13]	30/30	6/5	39/21	华蟾素注射液	美施康定片	28	①VAS 评分+③KPS 评分
温洋，2018[14]	41/41	5/5	48/35	氨酚羟考酮+华蟾素注射液	氨酚羟考酮	14	①VRS+③KPS 评分
黄志有，2016[15]	45/45	4	49/41	盐酸羟考酮控释片+华蟾素胶囊	盐酸羟考酮控释片	28	①NRS 评分+②+③BPI
王济国，2016[16]	144/144	41	159/129	盐酸羟考酮控释片+华蟾素注射液	盐酸羟考酮控释片	14	①NRS 评分+②+③KPS 评分
陈振鹏，2019[17]	60/60	12	70/50	盐酸羟考酮缓释片+华蟾素片	盐酸羟考酮缓释片	28	①NRS 评分+②+③KPS 评分
王芸，2018[18]	120/120	10/9	148/92	伊班膦酸钠注射液+华蟾素注射液	伊班膦酸钠注射液	28	①《临床肿瘤内科手册》标准+②+③KPS 评分
王卫华，2012[19]	30/30	不详	36/24	吗啡缓释片+元胡止痛胶囊	吗啡缓释片	7	①NRS 评分+②+③KPS 评分
吕任齐，2001[20]	91/30	不详	不详	复方桂参止痛合剂＋强痛定模拟片	复方桂参止痛合剂模拟＋强痛定片	7	①NRS 评分+②
钟进才，2004[21]	36/33	不详	39/30	桂参止痛合剂	路盖克	7	①NRS 评分+②+③数字标尺法
陈长怀，2000[22]	204/114	不详	不详	桂参止痛合剂＋强痛定模拟片	桂参止痛合剂模拟＋强痛定片	7	①NRS 评分+②+③KPS 评分
王薇，2021[23]	50/45	8/5	63/32	草乌甲素	布洛芬缓释胶囊/曲马多缓释片	7	①NRS 评分+②+③QOL-C30
周文丽，2005[24]	48/48	8	52/44	新癀片+美施康定	美施康定	7	①VRS 评分+②

骆学新，2000[25]	92	4	66/26	新癀片	无对照	不详	①《现代肿瘤学》疼痛分级+②+③KPS
林德荣，2014[27]	48/48	10	50/46	康莱特注射液+奥施康定	奥施康定	7	①NRS 评分+②+③BPQ
周长芳，2016[28]	60/60	8/8	68/52	康莱特注射液+吗啡类	吗啡类	42	①NRS 评分+③QOL
成建德，2009[29]	40/36	16	44/32	康莱特注射液+营养支持+三阶梯镇痛	营养支持+三阶梯镇痛	42	①VAS 评分+③KPS
李同度，1999[30]	376	28	233/143	康莱特注射液	无	20	①NRS 评分+②+③KPS\QOL-C30
杜敏，2015[31]	58/58	不详	52/64	康莱特胶囊+吗啡缓释片	吗啡缓释片	20	①VAS 评分+③SF-36
王彦宏，2015[32]	38/37	15	40/35	康莱特注射液+最佳支持治疗	最佳支持治疗	30	①WHO 实体瘤疗效诊断判断+③KPS
孙莹莹，2020[33]	30/30	30/30	31/29	康莱特注射液+化疗	化疗	28	①VAS 评分+②+③KPS
缪亚军，2011[34]	34/32	34/32	38/28	康莱特注射液+化疗	化疗	112	①NRS 评分+②+③KPS
吕伟华，2016[35]	36/36	11	42/30	湿润烧伤膏	红霉素软膏	不详	①国际抗癌联盟急性放射反应诊断标准、主诉疼痛分级标准
李艳丽，2007[36]	102/102	不详	124/80	如意金黄散	硫酸镁	7	①化疗药致静脉炎分级
郝建华，2018[40]	41/41	41/41	40/42	复方苦参注射液+化疗	化疗	63	①NRS 评分+②+③BPI-QOL
温艳艳，2019[41]	32/32	32/32	35/29	复方苦参注射液+盐酸羟考酮缓释片	盐酸羟考酮缓释片	10	①NRS 评分+②+③QOL-C30
费小东，2020[42]	50/50	50/50	58/42	复方苦参注射液+盐酸羟考酮缓释片	盐酸羟考酮缓释片	10	①NRS 评分+③WHOQOL-BREF
李爽，	30/30	30/30	29/31	艾灸配	西药止	14	①NRS 评分+③QOL

① 疼痛缓解率（要求有明确的疼痛评估指标及疗效评价标准）②不良反应发生率③生活质量评分

证据文献的 meta 分析结果

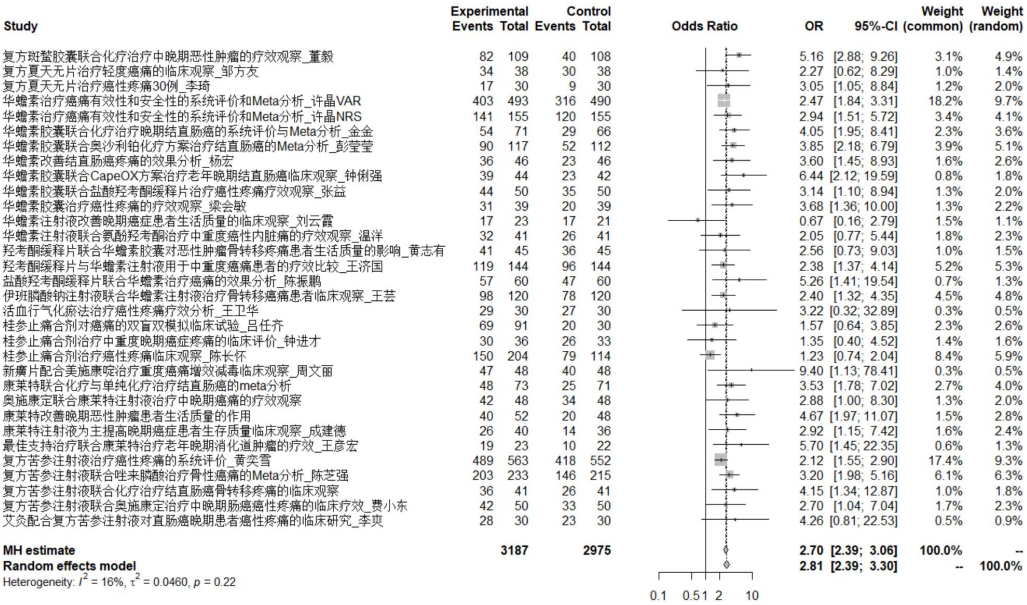


图 1 全部有效率-meta 分析

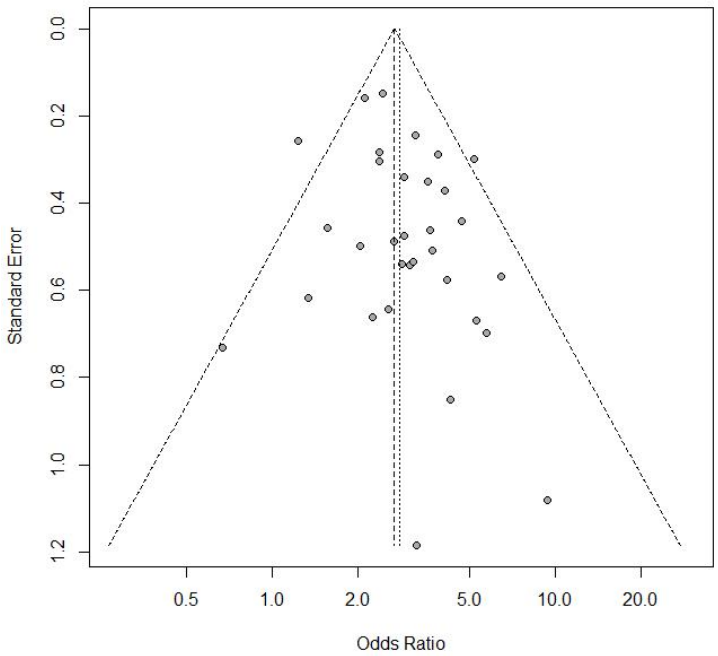


图 2 全部有效率-meta 分析-漏斗图

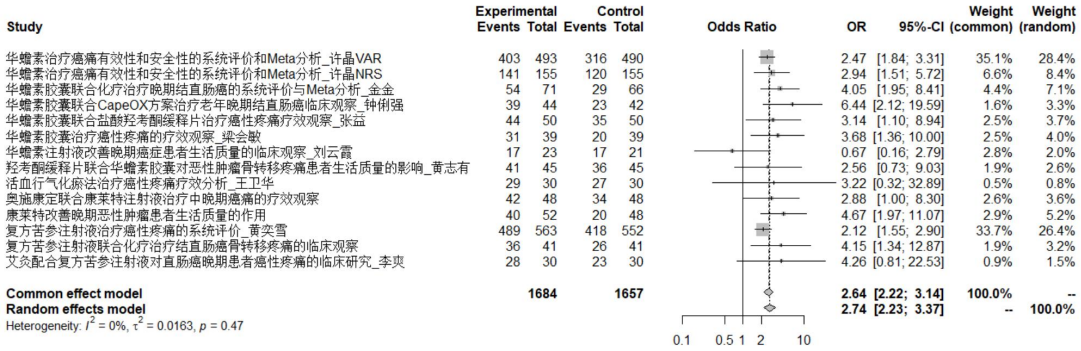


图 3 有效率评价方法：NRS 和 VAR

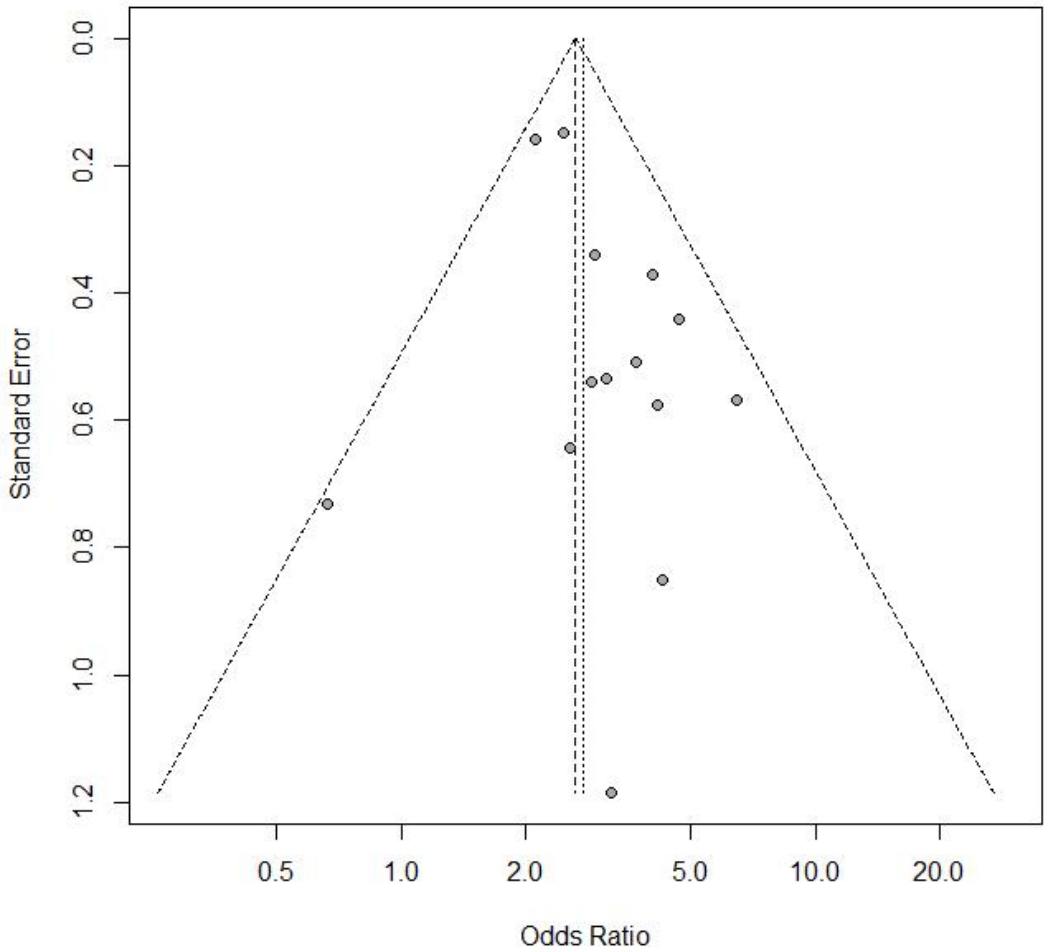


图 4 有效率评价方法：NRS 和 VAR-漏斗图

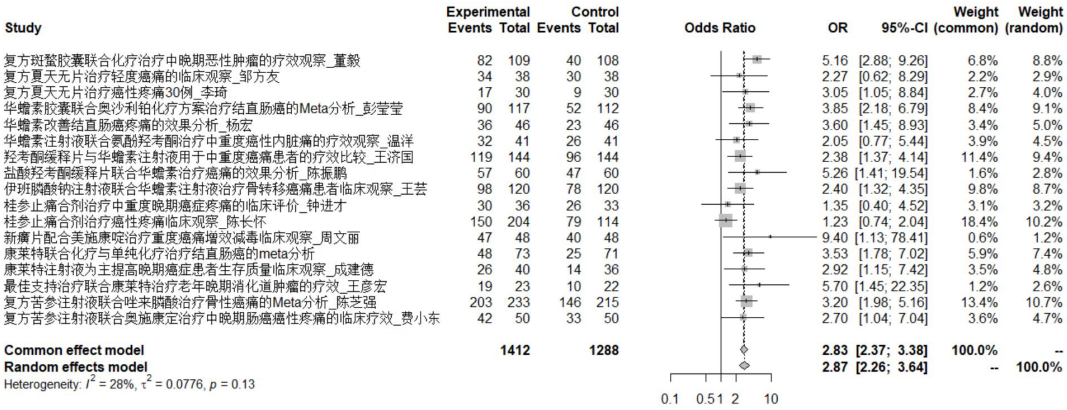


图 5 有效率其他方法评价

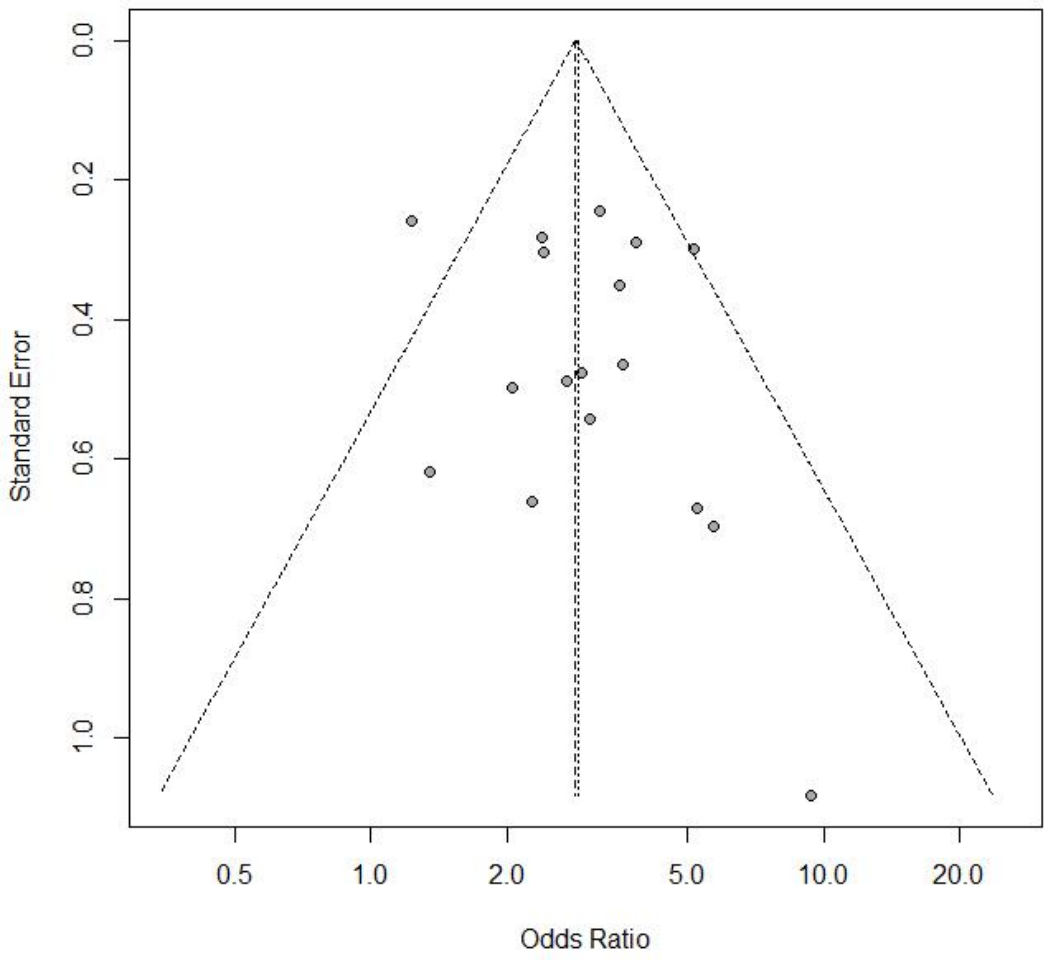


图 6 有效率其他方法评价-漏斗图

（七）推荐意见

1. 推荐意见形成方法

2021年12月27日于线上进行了该指南临推荐意见形成专家研讨会，由专家组对推荐意见形成进行投票，采用名义组法共识会议。详见附件12

2. 推荐意见投票结果

推荐意见投票结果表

序号	推荐条目	推荐方向强度的票数					投票轮数	是否达成共识
		↑↑	↑	／	↓	↓↓		
1	结直肠癌疼痛的中医辨证治疗（湿热证采用槐角丸，血瘀证采用血府逐瘀汤，气滞证采用六磨饮子，阳虚证采用理中汤，阴虚证采用芍药甘草汤）	1	8	2	0	0	1	是
2	复方斑蝥胶囊	0	11	0	0	0	1	是
3	复方夏天无片	0	10	0	1		1	是
4	华蟾素胶囊（片、注射液）	11	0	0	0	0	1	是
5	元胡止痛片（颗粒）	0	8	1	2	0	1	是
6	桂参镇痛合剂	7	2	0	2	0	1	是
7	草乌甲素片	6	5	0	0	0	1	是
8	新癀片	0	8	0	2	1	1	是
9	复方苦参注射液	10	1	0	0	0	1	是
10	康莱特注射液（胶囊）	5	6	0	0	0	1	是
11	湿润烧伤膏	3	7	0	1	0	1	是
12	如意金黄散	1	7	0	2	1	1	是
13	阴虚胃痛颗粒	0	1	0	7	3	1	
14	参芍片	0	2	0	6	3	1	
15	结直肠癌疼痛合并肠梗阻的中西医结合治疗（标准西医治疗+内服法、外治法、中药保留灌肠、中药穴位外敷、针灸治疗）	0	8	3	0	0	1	是
16	放射性直肠损伤的中西医结合治疗（标准西医治疗+内服法、外治法、中药保留灌肠、针灸治疗）	0	9	1	1	0	1	是

（八）撰写指南草案

指南草案的执笔人为李占东、崔宁，完成时间为 2022 年 1 月，李萍萍、吴煜对指南草案进行了修改和审核。

（九）指南草案的质量评价及适用性评价

1.质量评价

对指南进行质量评价的专家13名，具体姓名、单位、职务或职称如下：樊碧发，卫生部中日友好医院疼痛科，主任医师；侯丽，北京中医药大学东直门医院肿瘤科，主任医师；贾立群，卫生部中日友好医院肿瘤科，主任医师；刘端祺，北京军区总医院肿瘤科，主任医师；柳芳，卫生部中日友好医院药学部，副主任药师；李国辉，中国医学科学院肿瘤医院药学部，主任药师；李朋梅，卫生部中日友好医院药学部，主任药师；李小梅，中国人民解放军总医院南楼肿瘤科，主任医师；孙韬，北京中医药大学东方医院肿瘤科，主任医师；吴晓明，中国医学

科学院肿瘤医院综合科，主任医师；杨国旺，北京中医医院肿瘤科，主任医师；杨阳，生部中日友好医院疼痛科，副主任医师；张艳华，北京大学肿瘤医院药学部，主任药师。

对质量评价的主要结果进行总结，以表格形式汇总指南的质量评价结果。

指南质量评价结果

序号	条目内容	选择人数		
		是	否	不适用
1	指南制订小组由包含临床专家和方法学家在内的多学科团队组成	13	0	0
2	指南制订人员与指南内容无利益冲突	13	0	0
3	有构建清楚的临床问题	13	0	0
3.1	报告了中医病名或西医病名或具体中医证候	13	0	0
3.2	报告了干预措施的具体类型如汤药、中成药、针灸等	13	0	0
3.3	对照措施合理	13	0	0
3.4	结局指标是具有临床重要性，或能体现中医药治疗优势的指标	13	0	0
4	检索范围全面	13	0	0
4.1	检索内容包括了中医古籍文献与现代临床研究文献	13	0	0
4.2	报告了检索的数据库、检索时间、检索词	13	0	0
4.3	提供了代表数据库的具体检索策略	13	0	0
5	提供了纳入排除标准，并与临床问题相符	13	0	0
6	描述了文献筛选过程，并提供了清晰的筛选流程图	13	0	0
7	提供了排除文献列表	13	0	0
8	数据提取过程清晰	13	0	0
9	提供了纳入文献清单及纳入文献特征表	13	0	0
10	数据综合过程正确	13	0	0
10.1	效应值选择正确	13	0	0
10.2	统计分析方法正确	12	1	0
11	选用了国际或行业内公认的证据质量评价方法，且证据质量评价过程正确，前后无矛盾	11	2	0
12	提供了证据概要表	13	0	0
13	明确描述形成推荐意见的考虑要素	12	1	0
14	明确解释推荐强度的含义	13	0	0
15	明确描述形成推荐意见的方法，并提供了相关附件如调研问卷或会议记录	13	0	0
16	每条推荐意见均有证据支持	11	2	0

2.适用性评价

指南进行适用性评价的专家13名，具体同上。

表9 指南适用性评价结果

序号	条目	选择人数		
		是	否	不适用
领域1. 总体				
1	制定的机构组织及成员具有权威性	13	0	0
2	明确定义指南使用人群（中医医师/中西医结合医师/西医医师等）	13	0	0
3	明确定义指南适用环境（三级医院/二级医院/社区诊疗中心等）	13	0	0

4	指南内容全面	11	2	0
5	理、法、方、药一致	13	0	0
领域2. 清晰性				
1	推荐建议易于识别（在框中加粗，粗体文字，下划线等）	10	3	0
2	推荐意见表达用词明确，并列出每项推荐意见的证据等级	13	0	0
3	列出指南内包含的所有术语和英文译名，及其具体定义	13	0	0
4	指南中的临床问题明确，且与推荐意见前后一致	13	0	0
领域3. 可执行性				
1	指南使用人员可以理解指南内容	12	1	0
2	明确定义患者人群特征，必要时应列出不适用的亚组人群	13	0	0
3	疾病的病因清晰，有依据，并得到行业认同	13	0	0
4	疾病的病机清晰，有依据，并得到行业认同	13	0	0
5	中医常见证候清晰，有依据，并得到行业认同	13	0	0
6	对于推荐的方药，明确描述了具体组方	13	0	0
6.1	报告了方剂名称；	13	0	0
6.2	报告了方剂来源；	13	0	0
6.3	报告了方剂组成及每味中药的克数；	13	0	0
6.4	报告了用药方案；	10	3	0
6.5	报告了煎煮法（需要时列出）；	0	0	13
6.6	报告了加减用药方案（需要时列出）；	0	0	13
6.7	报告了注意事项	0	0	13
6.8	如果有合并治疗，描述合并治疗方案	0	0	13
6.8.1	合并治疗类型	0	0	13
6.8.2	合并治疗时机	0	0	13
6.8.3	合并治疗剂量/频次	0	0	13
6.8.4	合并治疗疗程	0	0	13
6.9	明确描述该方剂改善的结局	0	0	13
7	对于中成药，明确描述了下列信息	13	0	0
7.1	报告了用药方案；	13	0	0
7.2	报告了疗程；	13	0	0
7.3	报告了注意事项	13	0	0
7.4	如果有合并治疗，描述合并治疗方案	13	0	0
7.4.1	合并治疗类型	0	0	13
7.4.2	合并治疗时机	0	0	13
7.4.3	合并治疗剂量/频次	0	0	13
7.4.4	合并治疗疗程	0	0	13
7.5	明确描述该中成药改善的结局	13	0	0
7.6	该中成药是否属于医保药物或基药	13	0	0
8	对于非药物疗法（如针刺，推拿等），提供足够详细信息，以允许临床医师可以进行相关操作	0	0	13
8.1	针刺	0	0	13
8.1.1	报告了针刺的穴位	0	0	13
8.1.2	报告了针刺的深度	0	0	13
8.1.3	报告了针刺的刺激方式	0	0	13
8.1.4	报告了留针时间	0	0	13
8.1.5	报告了治疗频次	0	0	13
8.1.6	报告了疗程	0	0	13
8.1.7	必要时报告联用的其他干预措施	0	0	13
8.1.8	明确描述该疗法改善的结局	0	0	13

8.2	灸法	0	0	13
8.2.1	报告了灸法的适用情况	0	0	13
8.2.2	报告了某灸法的操作要点	0	0	13
8.2.3	报告了治疗频次	0	0	13
8.2.4	报告了灸法的疗程	0	0	13
8.2.5	明确描述该疗法改善的结局	0	0	13
8.3	推拿	0	0	13
8.3.1	报告了推拿手法	0	0	13
8.3.2	报告了推拿时间	0	0	13
8.3.3	报告了治疗频次	0	0	13
8.3.4	报告了疗程	0	0	13
8.3.5	明确描述该疗法改善的结局	0	0	13
8.4	针刀疗法	0	0	13
8.4.1	报告了无菌操作要点	0	0	13
8.4.2	报告了进针的取穴部位	0	0	13
8.4.3	报告了进针的深度	0	0	13
8.4.4	报告了进针手法的操作要点	0	0	13
8.4.5	报告了治疗频次	0	0	13
8.4.6	报告了疗程	0	0	13
8.4.7	必要时报告联用的其他干预措施（如推拿）	0	0	13
8.4.8	明确描述该疗法改善的结局	0	0	13
8.5	敷贴、熏洗	0	0	13
8.5.1	报告了贴敷片剂治疗的部位或熏洗的部位	0	0	13
8.5.2	报告了治疗频次	0	0	13
8.5.3	报告了疗程	0	0	13
8.5.4	必要时报告联用的其他干预措施	0	0	13
8.5.5	明确描述该疗法改善的结局	0	0	13
8.6	耳穴	0	0	13
8.6.1	报告了耳穴刺激的穴位	0	0	13
8.6.2	报告了治疗频次	0	0	13
8.6.3	报告了疗程	0	0	13
8.6.4	必要时报告联用的其他干预措施	0	0	13
8.6.5	明确描述该疗法改善的结局	0	0	13
8.7	传统功法（太极、气功等）	0	0	13
8.7.1	报告了具体功法的名称	0	0	13
8.7.2	报告了练功的频次与时长	0	0	13
8.7.3	报告了练功的注意事项	0	0	13
8.8	其他非药物疗法	0	0	13
9	必要时可针对性提出预防调护的措施	0	0	13
10	必要时可针对性提出康复调摄的措施	0	0	13

3.评价结果分析

分析记录质量评价和适用性评价结果，根据其结果，对指南草案进行了一定的完善，最终形成征求意见稿。

（十）征求意见

征求意见自2022年3月1日至3月15日。对象地区涵盖5个省市，18家医院。共50名临床医生。其中主任医师占30%，副主任医师占40%，主治医师占15%，住院医师15%。医院包括：中国医学科学院肿瘤医院、中日友好医院、北京市朝阳区

桓兴肿瘤医院、北京世纪坛医院、北医三院、北京朝阳医院、中国中医科学院广安门医院、首都医科大学附属北京中医医院、东方医院、首都医科大学大兴医院、大兴区人民医院、望京医院、东直门医院、山西省临汾市第二人民医院、临汾市中医医院、江西省肿瘤医院、青岛市中心医院、贵州中医药大学第一附属医院。

征求意见汇总处理表

序号	章条编号	草案内容	提出单位和姓名	反馈意见内容及理由	意见处理情况
1	7.5	阿片类药物引起的便秘中成药的使用	贵州中医药大学第一附属医院，唐东昕	应该增加专家推荐意见	因循证医学证据不足，无法做出专家推荐意见
2	7.3.3	结直肠癌疼痛的中医辨证治疗	青岛市中心医院，姜玉华	应该增加专家推荐意见	同意，增加了推荐意见
3	7.3.4	参芍片、阴虚胃痛颗粒	江西省肿瘤医院，郑智	参芍片、阴虚胃痛颗粒在结直肠癌疼痛中不常用，建议删除	同意，删除
4	7.6	结直肠癌常见疼痛的中西医结合诊疗方案（结直肠癌疼痛合并肠梗阻、放射性直肠损伤）	东方医院，孙韬	增加中医外治内容	同意，重新检索文献并增加了外治发内容

（十一）送审

记录提交审查的时间，标准化办公室形式审核意见及处理情况。记录审查会议的情况，包括会议时间、评审专家、评审意见和意见处理情况。

四、与国内外同类指南的对比和最新指南采用情况

（一）国内外无同领域指南

五、与现行强制性国家标准或政策法规的关系

与现行强制性国家标准及政策法规无矛盾或冲突。

六、代表性分歧意见的处理经过和依据

对于整个编制过程中未涉及到代表性的重大分歧意见。

七、宣传、贯彻指南和后效评价指南的要求和措施

（一）宣传、贯彻指南的措施

1. 指南的实施单位

本指南发布后，拟先行在北京大学肿瘤医院和中国中医科学院西苑医院实施。

2. 其他宣传、贯彻本指南的措施

（1）宣贯团队的人员名单： 李萍萍、吴煜、李占东、王薇、孙红等。

（2）宣贯场次及规模：2 场，50 人/次

（2）半年内完成用户报告

（4）两年内完成实施效果报告如开展指南培训，需说明培训场次数量、基本规模等方面内容；如开展指南合作，需说明企业或相关单位采标、合作等方面内容；如媒体宣传：需说明新闻发布、媒体报道等方面的内容；如发表论文，需说明研究成果发表发布层级数量等方面的内容等。

（二）指南的用户评价

描述拟于何时开展指南的用户评价及用户评价的方案。

（三）指南的修订

描述拟于何时对本指南进行更新或修订，及更新或修订所遵循的标准。

八、废止现行有关指南的建议

对于修订版的指南，描述本版本与前一版本的区别，是否建议废止前一版本的指南。

九、相关附录

见附件 1-12